

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5009821-94.2025.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: ERICK CAUA DOMINGOS LEITE

RECORRENTE: VALERIA DOMINGOS

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

MEDIDA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE MARCAÇÃO DE CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR, COM RISCO AMARELO DEVIDO AO QUADRO DE MALFORMAÇÃO VASCULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Sem honorários, considerando a natureza da causa. Com o trânsito em julgado, arquite-se o processo, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5009821-94.2025.4.02.5101

510015703650 .V6

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5009821-94.2025.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: ERICK CAUA DOMINGOS LEITE

RECORRENTE: VALERIA DOMINGOS

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta por **ERICK CAUA DOMINGOS LEITE**, em face da decisão proferida nos autos originários (nº **50967004120244025101** - Evento 14, DESPADEC1), que indeferiu a antecipação da tutela por meio da qual pleiteia marcação de cirurgia vascular, sob a alegação de “RISCO AMARELO”.

A liminar foi indeferida (Evento 3, DESPADEC1).

No evento 12 e 15 a UNIÃO e o ESTADO DO RIO DE JANEIRO apresentaram contrarrazões, respectivamente.

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, no caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão (Evento 3, DESPADEC1), a qual passa a integrar o presente voto:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de medida de urgência em face da decisão, verbis: (evento 14, DESPADEC1)

"ERICK CAUA DOMINGOS LEITE, neste ato representado por VALERIA DOMINGOS, propõe a presente demanda, com pedido de antecipação de tutela, por meio da qual a parte autora, com quadro de má formação venosa, requer a condenação da União Federal, do Estado/RJ e

do Município do Rio de Janeiro, em responsabilidade solidária, na obrigação de realizarem consulta em cirurgia vascular - doença venosa, de acordo com as suas necessidades clínicas.

Parecer técnico acostado pelo NAT-Jus no evento 6.1.

Passo a decidir.

Inicialmente, de acordo com a documentação médica que instrui a exordial, verifico que o autor apresenta quadro de malformação venosa em membro inferior direito, com requerimento para realização de consulta em cirurgia vascular.

Acerca da condição clínica do paciente, o órgão técnico destacou o seguinte:

"As malformações vasculares são categorizadas conforme a natureza dos canais vasculares (capilares, arteriais, venosos ou linfáticos). Deve ser ressaltado que é comum a coexistência dos diferentes vasos em uma mesma lesão. Além disso, várias afecções apresentam características, padrões de distribuição e associações com outras alterações morfológicas comuns e, sendo, por essa razão, referidas como síndromes e geralmente denominadas por epônimos. As malformações vasculares podem ser divididas em duas categorias: de alto ou baixo fluxo. As de alto fluxo compreendem malformação arterial (MA), fístula arteriovenosa (FAV) ou malformação arteriovenosa (MAV). As de baixo fluxo são malformação venosa (MV), malformação linfática (ML) e malformação capilar (MC). A abordagem multidisciplinar é necessária não apenas para o diagnóstico, mas também para o tratamento das malformações vasculares".

Nesse contexto, informa-se que a consulta vindicada está indicada para o quadro do autor e, além disso, que é procedimento coberto pelo SUS, consoante consulta a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais do SUS (SIGTAP).

Com o intuito de verificar o correto encaminhamento do paciente junto aos sistemas de regulação, em consulta realizada na plataforma da Secretaria Municipal de Saúde - Transparência do SISREG Ambulatorial, foi identificada uma solicitação de consulta em cirurgia vascular - doença venosa, com classificação de risco "amarelo - urgência", solicitada em 12/08/2024, com situação: "Agendamento / Falta / Executante", unidade executante Hospital Federal Cardoso Fontes, datada de 12/09/2024.

Tendo em vista as informações acima, a parte autora foi intimada a fim de que se manifestasse acerca do agendamento em questão, esclarecendo se compareceu à mencionada consulta.

Em resposta, o autor informou que só foi comunicado da consulta no mesmo dia de sua realização e, por esse motivo, não foi possível comparecer ao referido agendamento.

Para o deferimento da tutela jurisdicional liminar, impõe-se a demonstração, de plano, de alta probabilidade quanto ao direito pretendido e, ainda, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do CPC), ou do abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, por parte do réu (art. 311, I, do CPC).

O caso concreto deve ser analisado à luz do disposto no art. 196 da Constituição Federal, que outorga verdadeiro direito subjetivo aos que necessitem dos serviços públicos de assistência à saúde, incumbindo ao Poder Público a tarefa de concretizá-lo (Nesse sentido: STF, RE-271286/RS, Relator Min. Celso de Mello, DJ 23/08/2000).

Do mesmo modo, o art. 198 do Texto Maior, ao dispor sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), estabelece que este será financiado pela União, Estados-membros e Municípios, do que decorre a responsabilidade solidária dos referidos entes públicos.

Como forma de garantia e preservação da saúde, encontra-se incluído no campo de atuação do SUS a assistência terapêutica integral, nos termos do inciso, I, alínea d, do art. 6º da Lei nº 8.080/1990.

Cuida-se, portanto, de direito fundamental, consectário lógico do princípio da dignidade da pessoa humana e indissociável do direito à vida. Admite-se, assim, que o titular de tal direito possa postular, por meio da via judicial, prestação positiva do Estado que imprima ao comando constitucional eficácia plena.

Lado outro, não se pode olvidar de que o próprio art. 196 em comento estabelece a garantia do acesso universal e igualitário às ações e serviços direcionados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

Nesse diapasão, impende observar a "reserva do possível", sob pena de ocasionar indesejáveis situações anti-isonômicas. Com efeito:

"o direito à saúde, positivado no art. 196 da Constituição, não significa acesso irrestrito a todo tipo de assistência médico-hospitalar, segundo a conveniência de cada paciente, cujas pretensões singulares ou atípicas, se atendidas sem juízo de ponderação e indiscriminadamente, podem comprometer a governança das redes públicas de saúde, vulnerando o ideal republicano da igualdade de todos perante a lei. Para não afetar o princípio da separação dos poderes, o Poder Judiciário só pode intervir nos critérios do SUS para afastar ilegalidades, sendo insuficientes a tal desiderato a mera exibição de laudos médicos, particulares ou oficiais, visto que na saúde pública os tratamentos sujeitam-se a múltiplos fatores, a saber: indisponibilidade momentânea do tratamento ou falta de leitos

hospitais; carência de recursos orçamentários; limitações terapêuticas e de ofertas de remédios; insuficiência de médicos, enfermeiros e auxiliares; a fase evolutiva de medicamentos até a sua aprovação definitiva pelos órgãos competentes" (TRF2, Sexta Turma Especializada, AG - Agravo de Instrumento - 233160, Des. Fed. Nizete Lobato Carmo, DJe 06/02/2014).

Nessa toada, insta dizer que, não obstante a urgência de cada caso concreto, não se pode perder de vista a possibilidade de haver outras tantas urgências ainda maiores aguardando o mesmo tipo de tratamento. Sob esse prisma, a eventual imposição do fornecimento aleatório e indiscriminado de certo tratamento tem o potencial de inviabilizar o próprio sistema de saúde pública.

Cabe, portanto, à Administração Pública a tarefa de organizar a fila de espera para a prestação de serviços de saúde. A intervenção do Poder Judiciário nessa seara só se legitima quando flagrante o desrespeito à ordem da fila de espera, ou em caso de risco iminente de morte, tudo em consonância com o princípio da igualdade que deve existir entre todos os pacientes.

É importante ressaltar que a fila de espera é formada e ordenada a partir de critérios médico-científicos, de modo que o Poder Judiciário não pode substituir, sem base em argumento técnico-pericial, a critério de prioridade médica para a realização de tratamentos efetuado pelos profissionais da própria área.

Com efeito, há uma fila de espera em razão do procedimento administrativo dos órgãos públicos que, para atender em igualdade de condições a todos, adota como critério de seleção a inscrição na central de regulação de leitos. Ou seja, trata-se de critério que, ante a impossibilidade de tratamento imediato de todos, atende ao princípio constitucional da isonomia.

Assim, sem que esteja presente a demonstração de ilegitimidade da fila, qualquer decisão judicial determinando transferência hospitalar imediata caracterizaria desrespeito ao acesso igualitário ao serviço de saúde, ante a situação comum em que se encontram os vários pacientes da fila, que podem estar em situação igual ou pior que a demandante.

Neste sentido é a jurisprudência do E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao se referir à fila de espera:

"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. INCA. CIRURGIA. FILA DE ESPERA. LEI Nº 12.732/12. NECESSIDADE DE DIAGNÓSTICO EM LAUDO PATOLÓGICO.

1. Com a vigência da Lei nº 12.732/12, verifica-se que o paciente com neoplasia maligna passou a ter o direito de receber, gratuitamente, no Sistema Único de Saúde, todos os tratamentos necessários. Ademais, a mesma lei dispõe em seu art. 2º que "o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único".

2. Todavia, em que pese o direito concedido ao agravado, é certo que não cabe ao Judiciário interferir nos critérios médicos utilizados para a organização da fila de atendimento. Precedentes TRF2.

3. Não cabe ao magistrado determinar os indivíduos que serão agraciados por uma vaga no instituto especializado ou em qualquer outro hospital da rede pública, uma vez que este não possui uma visão global acerca da situação dos demais pacientes. Deve-se respeitar a fila administrativamente formada com base em critérios médicos.

4. Embora o direito à saúde seja constitucionalmente garantido a todos, cabendo ao Estado, em sentido lato, promovê-lo mediante política sociais e econômicas (arts. 6º e 196 da CRFB/88), não se pode prejudicar outras pessoas em igual ou até pior situação, que têm prioridade na fila organizada administrativamente, sob pena de afronta ao princípio da isonomia.

5. Cabe à Administração Pública, mediante exame com base em critérios técnicos, aferir a possibilidade de internação no INCA ou em qualquer outro hospital da rede pública, respeitando a fila administrativamente estabelecida.

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido."

(TRF2; Processo AG201302010107334; AG - 232519; Relator (a) Desembargador Federal José Antonio Lisboa Neiva; Órgão julgador: Sétima Turma Especializada; Data::17/12/2013). (Grifei)"

Impende registrar que não se desconsidera a situação pela qual passa a parte autora, em virtude do quadro de saúde apresentado. Contudo, não se vislumbra no caso razão suficiente para que se privilegie um paciente em detrimento dos outros integrantes da fila de espera do SUS, e que também aguardam por tratamentos médicos.

Decerto, em casos como o que ora se apresenta, o Magistrado deve ter uma visão macro do direito à saúde pleiteado, de maneira que, ao fazer justiça àquele que recorre ao Poder Judiciário, não pode cometer injustiça no que tange aos demais pacientes que aguardam a

realização de consultas ou tratamentos, mediante inclusão na fila de espera.

Ademais, como salientado pelo órgão técnico, o ingresso dos usuários nas unidades que ofertam os serviços do SUS, ocorre por meio do sistema de regulação, para qualificar a atenção e o acesso da população às ações e aos serviços de saúde, não através de provimento judicial nesse viés.

Inclusive, salienta-se que o agendamento em tela ocorrera em setembro de 2024, de modo que não há qualquer indício nos autos que o paciente tenha tentado realizar nova consulta desde então.

Com efeito, não cabe ao Magistrado determinar quais indivíduos serão contemplados com o procedimento em unidade de saúde especializado ou em qualquer outro hospital da rede pública, por não possuir visão global acerca da situação dos demais pacientes, nem conhecimento sobre as prioridades, as enfermidades e a urgência de todos aqueles que aguardam a realização do mesmo tratamento.

Desta forma, em sede de cognição sumária, não se verifica no caso a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela, sendo necessário que o paciente busque a via administrativa para obtenção do atendimento almejado, não havendo qualquer comprovação de mora ou negativa da administração que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Ante o exposto, **INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.**

Citem-se para oferecimento de resposta, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 9º da Lei nº 9.099/95), devendo os réus apresentarem toda a documentação de que disponham para esclarecimento da causa, na forma do art. 11 da Lei nº 10.259/2001, bem como indicando, justificadamente, as provas que pretendem produzir, ou havendo possibilidade de conciliação, esta deve ser clara, detalhando todos os seus termos.

Deixo de designar audiência de conciliação, instrução e julgamento, pois a não realização não importa em prejuízo para as partes.

P.I."

Afirmou que não houve o agendamento de novas consultas em seu nome e prazo para atendimento a paciente em risco amarelo se esgotou, sem que nenhuma providência do Poder Público fosse efetivada. Requereu a consulta em cirurgia vascular – doença venosa.

É o breve relatório.

Sabe-se que são requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência: a) a probabilidade do direito pleiteado, ou seja, uma plausibilidade lógica que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, do que decorre um provável reconhecimento do direito, baseada em uma cognição sumária; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso não concedida, ou seja, quando houver uma situação de urgência em que se não se justifique aguardar o desenvolvimento natural do processo sob pena de ineficácia ou inutilidade do provimento final.

A parte autora não comprovou os requisitos.

O NAT juntou parecer no evento 14, DESPADEC1.

PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS-FEDERAL Nº 2066/2024

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2024.

Processo nº 5096700-41.2024.4.02.5101,
ajuizado por **Erick Cauã Domingos Leite**,
representada por **Valéria Domingos**.

Trata-se de Autor com quadro clínico de **malformação venosa em membro inferior direito** (Evento 1, ANEXO2, Páginas 15 e 16; Evento 1, ANEXO3, Página 1), solicitando o fornecimento de **consulta em cirurgia vascular** (Evento 1, INIC1, Página 9).

As **malformações vasculares** são categorizadas conforme a natureza dos canais vasculares (capilares, arteriais, **venosos** ou linfáticos). Deve ser ressaltado que é comum a coexistência dos diferentes vasos em uma mesma lesão. Além disso, várias afecções apresentam características, padrões de distribuição e associações com outras alterações morfológicas comuns e, sendo, por essa razão, referidas como síndromes e geralmente denominadas por epônimos. As malformações vasculares podem ser divididas em duas categorias: de alto ou baixo fluxo. As de alto fluxo compreendem malformação arterial (MA), fistula arteriovenosa (FAV) ou malformação arteriovenosa (MAV). As de baixo fluxo são malformação venosa (MV), malformação linfática (ML) e malformação capilar (MC). A abordagem multidisciplinar é necessária não apenas para o diagnóstico, mas também para o tratamento das malformações vasculares'.

Diante do exposto, informa-se que a **consulta em cirurgia vascular está indicada** ao manejo da condição clínica do Autor - **malformação venosa em membro inferior direito** (Evento 1, ANEXO2, Páginas 15 e 16; Evento 1, ANEXO3, Página 1). Além disso, **está coberta pelo SUS** conforme consulta a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais do SUS (SIGTAP), na qual consta: **consulta médica em atenção especializada**, sob o seguinte código de procedimento: 03.01.01.007-2, considerando o disposto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES).

Quanto ao **ente** responsável pelo eventual cumprimento da obrigação em tela, ressalta-se que para regulamentar o acesso aos procedimentos cardiovasculares incorporados no SUS, o Ministério da Saúde publicou a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017², que estabelece a Política Nacional de Atenção Cardiovascular de Alta Complexidade (Anexo XXXI), prevendo a organização de forma articulada entre o **Ministério da Saúde, as Secretarias de Estado da Saúde e do Distrito Federal e as Secretarias Municipais de Saúde**, por intermédio de redes estaduais e regionais, bem como contando com os Componentes da Atenção Básica, Especializada e das Redes de Atenção em Cardiologia Regional de cada unidade federada.

Destaca-se que no Estado do Rio de Janeiro, foi pactuado na Comissão Intergestores Bipartite a CIB-RJ nº 5.890 de 19 de julho de 2019, que aprova a recomposição da Rede de Atenção em Alta Complexidade Cardiovascular do Estado do Rio de Janeiro (ANEXO I). Assim, o Estado do Rio conta com as unidades habilitadas no SUS para atenção cardiológica e suas referências para as ações em cardiologia de média e alta complexidade por Região de Saúde no Estado do Rio de Janeiro.

O ingresso dos usuários nas unidades que ofertam os serviços do SUS, ocorre por meio do sistema de regulação, conforme previsto na Política Nacional de Regulação que organiza o serviço em três dimensões (Regulação de Sistemas de Saúde, Regulação da Atenção à Saúde e Regulação do Acesso à Assistência) para qualificar a atenção e o acesso da população às ações e aos serviços de saúde.

Em consulta à plataforma da Secretaria Municipal de Saúde – Transparência do SISREG Ambulatorial (ANEXO II), foi localizado para o Autor solicitação de **consulta em cirurgia vascular - doença venosa**, diagnóstico: **varizes dos membros inferiores sem úlcera ou inflamação**, classificação de risco: **Amarelo – urgência**, solicitada em 12/08/2024, pela Centro Municipal de Saúde Maria Aparecida de Almeida, situação: **Agendamento / Falta / Executante**, unidade executante **Hospital Federal Cardoso Fontes**, data: **12/09/2024**.

Informa-se que a via administrativa para o caso em tela já foi utilizada. Assim, sugere-se que seja questionado junto ao Autor acerca do comparecimento à consulta informada no SISREG.

Por fim, salienta-se que informações acerca de **custo de atendimento hospitalar não constam** no escopo de atuação deste Núcleo

É o parecer.

À 35ª Vara Federal do Rio de Janeiro, da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, para conhecer e tomar as providências que entender cabíveis.

LAMIRO MARCELINO RODRIGUES DA SILVA
Assistente de Coordenação
ID. 512.3948-5


VIRGINIA GOMES DA SILVA
Enfermeira
COREN/RJ 321.417
ID. 4.455.176-2

O NAT informou que foi localizado para o Autor solicitação de consulta em cirurgia vascular - doença venosa, diagnóstico: varizes dos membros inferiores sem úlcera ou inflamação, classificação de risco: Amarelo - urgência, solicitada em 12/08/2024, pela Centro Municipal de Saúde Maria Aparecida de Almeida, situação: Agendamento / Falta / Executante, unidade executante Hospital Federal Cardoso Fontes, data: 12/09/2024.

Aduziu que a via administrativa para o caso em tela já foi utilizada e sugeriu que a parte autora compareça à consulta informada no SISREG.

A parte autora informou que não compareceu à consulta agendada no dia 12/09/2024 no Hospital Federal Cardoso Fontes porque a agente de saúde da UBS só informou sobre o procedimento no mesmo dia do atendimento, impossibilitando o comparecimento.

Todavia, não há nos autos comprovação de que a parte autora tentou marcar nova consulta e que foi negado o agendamento.

A organização da fila de espera é baseada em critérios médico-científicos, de forma que a intervenção do Poder Judiciário só pode se dar em hipóteses excepcionais, em casos de flagrante desrespeito à regulação ou de urgência devidamente comprovada, nos termos do Enunciado 51 da II Jornada de Saúde do CNJ:

*"ENUNCIADO Nº 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, **com expressa menção do quadro clínico de risco imediato**."*

Assim, em uma cognição sumária, pode-se concluir que está ausente a probabilidade do direito pleiteado. Por essas razões, indefiro o requerimento liminar de atribuição de efeito suspensivo ativo. Intimem-se."

Logo, a decisão liminar que indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ativo deve ser mantida, tal como lançada.

Por tais razões, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO**. Intimem-se. Sem honorários, considerando a natureza da causa. Com o trânsito em julgado, archive-se o processo.